

Fecha Última Actualización: 28-11-2022 9:25:33

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Mónica Del Carmen Farías Reyes
Edad : 70a 9m 9d
Dirección : Fco Coloane 1306 Departamento 17

Rut : 8.370.991-K
Fecha Nacto: 01/02/1952
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A282972
Sexo : Femenino
Teléfono : 942733089

N° Epicrisis
329751

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Geriatria

Fecha Ingreso : 07/10/2022 22:56

Días Estadía: 34

Unidad de Egreso : Medicina Agudos 2° Piso

Fecha Egreso : 10/11/2022 11:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Insuficiencia respiratoria aguda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Epicrisis
23/11/2022

Nombre: Mónica Farías Reyes

RUT: 8370991-K

Edad: 70 años

FECHA DE INGRESO HSR: 07/10/2022

FECHA DE INGRESO UGA: 09/10/2022

FECHA DE INGRESO UPC: 12/10/2022

FECHA DE INGRESO UTIM: 10/11/2022

FECHA DE INGRESO Sala: 16/11/2022

Contacto: Luis (hijo): 9 3315 2131. 9 4273 3089

Antecedentes:

- Mórbitos: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de etiología tabáquica, no usuaria de Oxígeno domiciliario, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, posible Lupus Eritematoso Sistémico (sin registro en sistema)
- Quirúrgicos: Apendicectomía hace 40 años aprox.
- Fármacos: Atorvastatina 20 mg al día, Losartán cada 12 horas, Bromuro de Ipratropio 2 puff cada 8 horas, Brexotide 2 puff cada 12 horas, HCT 12.5
- Alergias: (-)
- Hábitos: Tabaco (+, activo, Índice paquete-año de 25, 10 cig/día por 50 años), Alcohol (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: Hospital Padre Hurtado hace 1 año por exacerbación de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Motivo de Consulta: Disnea

Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos acude el 07/10/22 al servicio de urgencias por cuadro clínico de 2 días de evolución de disnea progresiva, aumento en cantidad de secreciones bronquiales y episodios de agitación.

Al ingreso destaca disnea de reposo, Hipertensión arterial, saturación de 77% ambiental, requiriendo oxígeno suplementario.

Fecha Epicrisis : 28/11/2022 09:25

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 28-11-2022 9:25:33

Página 2 de 4

Al laboratorio destaca: Hcto 51%, GB: 6790, PCR: 108, GSA: PO2 61 pH 7.29, PCR SARS-COV 2: negativo. Radiografía de Tórax con infiltrado intersticial confluyente peri bronquial bilateral.

Se inicia Ventilación mecánica no invasiva, broncodilatación, corticoides y antibióticos de primera línea e ingresa a UGA

Diagnósticos de ingreso a UGA:

1. Insuficiencia respiratoria aguda global:

- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica GOLD D exacerbada, tabaquismo activo IPA 25
- Posible Neumonía Adquirida en la Comunidad

2. Antecedentes: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de etiología tabáquica, no usuaria de Oxígeno domiciliario, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, posible Lupus Eritematoso Sistémico (sin registro en sistema)

Evolución durante Hospitalización:

1. Hemodinamia: Ingresas con tendencia a la hipertensión, y a posterior, en contexto de intubación cursa con hipertensión severa con necesidad de manejo con nitroprusiato. A posterior con hemodinamia estable, hipertensión en manejo con vasodilatadores orales, con buena respuesta, en monitorización no invasiva

2. Respiratorio: Al ingreso con ventilación mecánica no invasiva hasta el 11/10, donde por deterioro de mecánica ventilatoria, desaturación y compromiso de conciencia, se decide sedación, intubación orotraqueal y drogas vasoactivas, trasladándose a UPC. Se extuba de manera frustra el 20/10, y a posterior se autoextuba el 21/10, pasando a ventilación mecánica no invasiva, pero con nueva necesidad de intubación el 22/10

Finalmente, se logra extubación exitosa el 25/10, con 48 horas de ventilación mecánica no invasiva y a posterior paso a cánula nasal de alto flujo. Logra paso a naricera el 10/11, con saturación en rango para enfermedad pulmonar, con requerimientos intermitentes bajos de oxígeno a posterior. Se maneja con terapia depleitiva en dosis bajas a pesar de no tener diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, con buena respuesta

- Con kinesioterapia y broncodilatadores, evaluada por broncopulmonar, se agrega Brexotide de uso crónico, en planes de descenso de esteroides de forma ambulatoria, y control con Ecocardiograma transtorácico para búsqueda de Hipertensión Pulmonar asociada a Tromboembolismo pulmonar. Se evaluará uso de LAMA según suspensión de Tabaco y espirometría ambulatoria

Con seguimiento al alta

- Durante estadía en UPC, en contexto de falla respiratoria se pesquisó Tromboembolismo pulmonar segmentario y subsegmentario lobar superior izquierdo sin compromiso de cavidades derechas que se anticoagula con enoxaparina, y se inicia traslape a Anticoagulantes orales tras estabilidad, sin conflicto.

3. Infeccioso: Manejo inicial con ampi/sulba en contexto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada por posible Neumonía adquirida en la comunidad. Se cultiva el 11/10, sin microbiología aislada, se mantuvo ampi/sulba y se añade azitromicina por neumonía grave. En UPC con interurrencias:

- Infección del tracto urinario por E. cloacae complex Multisensible, tratado con amikacina

- Previo a traslado eleva Parámetros inflamatorios, se mantiene afebril. Se cultiva expectoración, rechazado, se inicia Imipenem de forma empírica (14/11), completando 5 días y suspendiendo, a posterior afebril, con parámetros inflamatorios bajos, sin conflicto

4. Gastrointestinal: Con historia de constipación crónica, se mantiene con Polietilenglicol, con buena respuesta

5. Rehabilitación: Fonoaudiología: Al traslado recibiendo régimen mixto, oral con compotas de frutas + enteral.

Kinesioterapia: En lo motor, logra sedente en borde de cama, bipedesta con asistencia. En rehabilitación multimodal

6. Neurológico: Evoluciona con delirium hipoactivo, en manejo con medidas ambientales, con buena respuesta.

Dado buenas condiciones, se decide alta con unidad de hospitalización domiciliaria, para destete de oxígeno, kinesioterapia respiratoria y motora

Diagnósticos de Alta:

1. Insuficiencia respiratoria aguda global en resolución:

- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica etapa GOLD E exacerbado, por neumonía adquirida en la comunidad sin microbiología aislada

- Ventilación mecánica invasiva 10/11-25/11 con 2 intentos frustrados de extubación, autoextubada

2. Tromboembolismo pulmonar segmentario y subsegmentario de lóbulo superior izquierdo, riesgo bajo, en anticoagulación

3. Antecedentes: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de etiología tabáquica, no usuaria de Oxígeno domiciliario, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, posible Lupus Eritematoso Sistémico (sin registro en sistema)

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida En La Comunidad (Nac) -

Condición de Egreso

Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinamia estable, afebril, con requerimientos bajos de oxígeno por naricera, logrando saturaciones adecuadas, en tratamiento anticoagulante por tromboembolismo.
En condiciones de alta para continuar con manejo y controles de forma ambulatoria

Últimos exámenes (22/11): GSV: pH 7.403/47.9/29.2, INR 2.73, TTPA 70.7

Plan Post Alta

Indicaciones al alta:

- Reposo relativo
- Régimen blando con líquidos, sin sal

Medicamentos:

Amlodipino 10 mg al día VO
Bisoprolol 2.5 mg día VO
Losartán 25 mg al día VO
Espironolactona 25 mg día VO
Berodual 2 puff c/8 hrs con aerocámara
Budesonida 2 puff c/12 hrs con aerocámara
Brexotide 1 puff cada 12 horas con aerocámara
Bromuro de ipratropio 2 puff SOS
Enoxaparina 60 mg c/12 hrs SC
Acenocumarol 2 mg al día de Lunes a Viernes, 1 mg al día Sábado y Domingo
Furosemida 5 mg al día VO
Clonazepam 0.5 mg VO PM SOS en caso de angustia/insomnio
Polietilenglicol 17 g en 200 cc de agua cada 8 horas VO SOS en caso de constipación

Controles:

- Control con broncopulmonar para seguimiento de Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica, evaluar adherencia a suspensión de tabaco, evaluar espirometría ambulatoria y eventual LAMA, y control con ecocardiograma transtorácico para pesquisa de hipertensión pulmonar en contexto de tromboembolismo.
- Control con Policlínico de tratamiento anticoagulante, para ajuste de esquema de acenocumarol en contexto de tromboembolismo pulmonar
- Se entrega orden para realizar ecocardiograma transtorácico, para pesquisa de eventual hipertensión pulmonar en contexto de tromboembolismo pulmonar y enfermedad pulmonar
- GES de ayudas técnicas para evaluar confección de instrumento para asistencia en movilización

Acudir al servicio de Urgencias en caso de dolor importante o fiebre que no responda a manejo con analgésicos, compromiso de conciencia, dificultad para respirar, o en caso de que lo estime conveniente

Indicaciones

Tipo de Reposo : X

Régimen Alimentario : X

Medicamentos :

Controles

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 28-11-2022 9:25:33

Página 4 de 4



Glenda Ortiz Reina

Becado/Residente

Pedro Pablo Donoso Lagos

Médico Tratante (Staff)

INTERNO